

Заболеваемость колоректальным раком и состояние хирургической помощи онкологическим больным с данной патологией в г. Алматы

Кайдаров Б.К.¹, Балтаев Н.А.², Афонин Г.А.¹, Мустафина А.Р.³, Абабакиев А.К.²

¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

²Городской онкологический диспансер г. Алматы

³НИИ фундаментальной и прикладной медицины им. Б.А.Атчабарова при КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

Рак толстой кишки (РТК) является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. Ежегодно данное заболевание диагностируется приблизительно у 1 млн. человек в мире. Ежегодное возникновение 50 новых случаев заболевания раком толстой кишки на 100 000 населения определяют 5% популяционный риск развития заболевания в течение жизни [1]. При этом заболеваемость колоректальным раком (КРР) и смертность от него имеют тенденцию к увеличению. Рост заболеваемости отмечается за последние годы во всем мире, особенно в Европе, США и странах СНГ [2]. Особенностью данного заболевания является длительный скрыто протекающий («доклинический») период, относительно раннее и быстрое метастазирование опухоли, что существенно ухудшает прогноз для больного, осложняет лечение и ставит под сомнение возможность радикального излечения пациента. По статистике у каждого третьего заболевшего раком толстой кишки на момент постановки диагноза выявляются отдаленные метастазы. Кроме того, 30-55% больных, получивших потенциально радикальное лечение по поводу КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или рецидива опухоли [3].

Наряду с этим, благодаря достижениям фундаментальной науки выявлен ряд молекулярно-биологических и генетических особенностей КРР, что кардинально изменило представления о механизмах развития и прогрессирования опухоли и тем самым открыло новые перспективы лечения больных этим заболеванием [4,5,6]. Несмотря на то, что основная часть РТК относится к спорадическим формам (т.е. возникающим под воздействием известных факторов риска развития данной патологии к которым относятся: т.н. «западный» рацион питания с потреблением большого количества мяса, мучных изделий, жиров животного происхождения и рафинированных продуктов питания, малоподвижный образ жизни, пожилой возраст), доля пациентов с онкологическиотягощенным анамнезом составляет 20–30%, а около 10% всего РТК развивается в соответствии с законами Менделя, т.е. является аутосомно-доминантным заболеванием [7]. Такие наследственные состояния, как семейный аденоматозный полипоз (САП), наследственный непиллозный КРР (ННКРР), синдромы Гарднера-Тернера, Пейтца-Егерса, Банайан-Рувалкаба, Блюма, болезнь Тюрко, ювенильный полипоз толстой кишки, предполагают развитие РТК в сочетании с опухолями других локализаций [8].

КРР является нозологией, при которой даже комплексное лечение при условии выполнения радикальной операции на протяжении последних десятилетий имеет, по сути, ограниченные достижения [9]. Причин тому несколько: как правило, КРР поздно диагностируется, на стадии, когда даже при отсутствии видимых (т.е. доступных инструментальному контролю) метастазов, наиболее вероятно наличие микрометастазов, которые и определяют дальнейшее течение заболевания и прогноз для больного. У молодых лиц в силу биологических особенностей организма (большой пул пролиферации клеток) болезнь рано и быстро прогрессирует с развитием отдаленных очагов метастатического опухолевого роста. Это особая категория больных,

Рассмотрены динамика заболеваемости и некоторые аспекты оказания специализированной хирургической помощи больным колоректальным раком в г. Алматы. Изложена роль хирургического метода в лечении больных КРР, характер и объем оперативного вмешательства в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса.

Dynamics of colon and rectal cancer morbidity and some aspects of surgical care in Almaty city are considered in the survey. Presented role of the surgical method in the treatment of patients with colorectal cancer, character and volume of operation, depended from localization and stage of the tumor process.

которые, как правило, обращаются за медицинской помощью к запущенным опухолевым процессом (например, с клиникой кишечной непроходимости), таким больным проводятся навлидизирующие операции с выведением колостомы, что резко снижает качество жизни. Даже при условии проведения радикальной операции, дополненной курсами адъювантной химио- или химиотаргетной терапии заболевание у таких больных, как правило прогрессирует, что приводит к фатальному исходу [10,11]. Вместе с тем следует отметить, что при обнаружении опухоли на ранних стадиях и адекватном лечении возможно достижение благоприятного результата в плане выживаемости и качества жизни больного.

По данным КазНИИОиР в 2009 г. в республике онкологическими организациями взято на учет 28424 человека, впервые заболевших злокачественными новообразованиями [12]. В абсолютных числах больных раком ободочной и прямой кишки в 2009 г. зарегистрировано соответственно 1224 и 1140 человек. В процентах заболеваемость на 100000 человек составила 7.7 для РТК и 7.2 для РПК. (для сравнения – в 2008 г. – в абсолютных числах зарегистрировано больных РТК 1154 и РПК 1132, на 100000 населения – 7.4 и 7.2% соответственно). Темпы прироста (в процентах) составили за год для РТК 4.4, для РПК – 0.9%. В общей структуре онкопатологии (совокупно у мужчин и женщин) рак ободочной кишки находился в 2009 г. на 8 месте – 4.2% от общего числа заболевших всеми формами ЗН, рак прямой кишки – на 9 месте – 3.9%. В структуре ЗН среди мужчин рак прямой кишки находится на 7 месте, составляя 4.4% (в 2008 г. – 7 место, 4.2%), рак ободочной кишки – на 8 месте, составляя 4.0% (в 2008 г. – 9 место, 3.8%). В структуре ЗН среди женщин рак ободочной кишки находится на 7 месте, составляя 4.3% (в 2008 г. – занимал 8 место, 4.3%).

Что касается заболеваемости по областям, то число первично зарегистрированных случаев онкопатологии в 2009 г. было больше, чем в 2008 (рост) в половине регионов республики, например в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, городах Алматы и Астана.

Выше среднереспубликанских значений оказались показатели заболеваемости Павлодарской (14.5‰), Северо-Казахстанской (14.1‰) областей, г. Алматы (12.1‰), Костанайской (11.5‰), Восточно-Казахстанской (11.0‰), Карагандинской (10.7‰), Акмолинской (10.1‰) областей и г. Астаны (8.8‰). РТК меньше всего болели жители Алматинской (4.5‰), Кызылординской (3.1‰) и Южно-Казахстанской областей (2.2‰). Рак прямой кишки в структуре ЗН составил 3.9% (4.0% в 2008 г.) и остался на 9 ранговом месте. В динамике заболеваемости раком данной локализацией отмечалась стабилизация и показатель составлял в 2009 г. 7.2‰ (в 2008 г. – 7.2‰). Высокие показатели заболеваемости определились в Павлодарской (14.5‰), Северо-Казахстанской (11.9‰), Костанайской (11.5%), Восточно-Казахстанской (11.2‰), Карагандинской (9.2%) областях, г. Алматы (9.5‰), Акмолинской и Западно-Казахстанской областях (8.4‰), г. Астане (7.7‰). Относительно низкие – в Атырауской (3.5‰), Кызылординской (3.2‰) и Южно-Казахстанской (3.2‰) областях.

Резюмируя приведенные и другие статистические данные можно сделать следующие выводы:

- заболеваемость раком прямой и ободочной кишки в республике возрастает

- возрастает смертность от этих форм рака
- в г. Алматы отмечался высокий процент запущенности при РТК и РПК

- РПК и РТК входят в число 9 основных форм рака, определяющих структуру онкопатологии в республике (рак ободочной кишки – 8 место, рак прямой кишки – 9 место)

- в г. Алматы отмечены высокие показатели заболеваемости колоректальным раком

- в структуре причин, определяющих смертность от онкологических заболеваний РТК находится на 7, а РПК – на 6 месте. Показатели смертности от этих форм рака также высоки в г. Алматы.

Соответственно ситуации с заболеваемостью КРР возрастают требования к оказанию специализированной онкологической помощи этой категории пациентов. Алматы – крупнейший мегаполис республики, который характеризуется полиэтническим составом населения, высоким уровнем притока внутренних мигрантов, разнообразной возрастной структурой и социальным уровнем населения. Все это обуславливает определенные закономерности в заболеваемости КРР.

Нами была изучена динамика заболеваемости КРР за период 2007-2010 гг. по данным канцер-регистра ГОД г. Алматы (данные только по г. Алматы)

Впервые взятые на учет больные в 2007 г:

Раком ободочной кишки 178 из них с IV стадией заболевания – 17

Раком прямой кишки 102, из них с IV стадией заболевания – 14

Впервые взятые на учет больные в 2008 г:

Раком ободочной кишки 176 из них с IV стадией заболевания – 21

Раком прямой кишки 106, из них с IV стадией заболевания – 14

Впервые взятые на учет больные в 2009 г:

Раком ободочной кишки 187 из них с IV стадией заболевания – 30

Раком прямой кишки 102, из них с IV стадией заболевания – 8

Впервые взятые на учет больные в 2010 г:

Раком ободочной кишки 217 из них с IV стадией заболевания – 28

Раком прямой кишки 119, из них с IV стадией заболевания – 19.

Приведенные данные свидетельствуют о значительных росте заболеваемости КРР (прирост больных в абсолютных числах) и темпе прироста заболеваемости КРР.

Возрастную структуру больных КРР иллюстрирует таблица 1.

Табл. 1. Распределение больных колоректальным раком по возрастам

год	Локализация	Возраст больных									итого
	С.18 Ободочная кишка	11 -20	21 -30	31 -40	41 -50	51 -60	61 -70	71 -80	81 и более		
2007			2	8	32	104	150	184	58	538	
2008			1	10	40	111	155	198	89	604	
2009			3	10	40	137	151	235	105	681	
2010		1	2	12	28	136	171	227	131	708	
С.19											
Ректосигмоидный переход											
2007			2		15	23	41	54	27	162	
2008			2		9	28	37	56	33	165	
2009			1	2	7	30	33	57	42	172	
2010				3	7	32	31	56	43	172	
С. 20											
Прямая кишка											
2007		1		7	25	85	102	105	47	372	
2008			3	5	28	96	91	126	59	408	
2009			3	8	23	99	100	140	78	451	
2010		1	3	9	21	102	110	143	82	471	

В таблице 2 приведена структура распределения больных КРР по клиническим группам.

Табл. 2. Распределение больных колоректальным раком по клиническим группам

Год	Всего больн.	Из них по клиническим группам					
		II клин. группа		III клин. группа		IV клин. группа	
		Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
2007	538	455	84.57	53	9.85	29	5.39
2008	604	513	84.93	53	8.77	37	6.13
2009	681	577	84.73	54	7.93	49	7.2
2010	708	613	86.58	45	6.30	49	6.92

Прямая кишка

Год	Всего больн.	Из них по клиническим группам					
		II клин. группа		III клин. группа		IV клин. группа	
		Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
2007	544	484	88.97	28	5.15	31	5.7
2008	585	523	89.4	29	4.96	32	5.47
2009	635	571	89.92	29	4.57	34	5.35
2010	659	587	89.07	31	4.7	40	6.07

Данные канцер-регистра ГОД г. Алматы отражают закономерности, которые характерны для данной нозологии, и опубликованные по материалам других специализированных клиник. В частности, сохраняется доля больных, регистрируемых впервые с запущенными (III и IV) стадиями заболевания (таблица 3).

Несмотря на совершенствование методов обследования больных с применением рентгенодиагностической и эндоскопической техники, расширение сети хорошо оснащенных диагностических центров, до настоящего времени не удалось существенно улучшить положение с ранним выявлением колоректального рака: больные поступают на лечение в стационары в основном с III-IV стадией заболевания [14]. Анализируя

Табл. 3. Распределение больных КРР по стадиям

Локализация	год	Всего больн.	Из них по стадиям					
			I-II стадия		III стадия		IV стадия	
			Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Рак ободочн. кишки	2007	538	148	27.51	350	65.06	33	6.13
	2008	604	168	27.81	386	63.91	43	7.12
	2009	681	199	29.22	423	62.11	52	7.64
	2010	708	218	30.79	431	60.88	52	7.34
Рак прямой кишки	2007	544	263	48.35	236	43.38	39	7.17
	2008	585	298	50.94	241	41.2	40	6.3
	2009	635	326	51.34	263	41.41	40	6.3
	2010	659	343	52.05	263	39.91	47	7.13

данные алматинского канцер-регистра, мы убедились, что свыше 50% больных раком ободочной кишки в мегаполисе Алматы попадают в общехирургические стационары в связи с возникновением грозных осложнений основного заболевания: острой толстокишечной непроходимости, перфорации опухоли и перитонита. В хирургических отделениях таким больным оказывают экстренную хирургическую помощь по жизненным показаниям и не всегда в необходимом объеме. Специфического противоопухолевого лечения в этих условиях больной не получает.

Иная ситуация складывается при первичном обращении больного или направления его районным онкологом или специалистом общей лечебной сети сразу в онкологическое учреждение, где больному проводится адекватный объем обследования для оценки степени распространенности и выбор лечебной тактики с учетом предоперационной стадии заболевания. В частности по материалам ГОД г. Алматы отмечается увеличение количества больных, впервые взятых на учет с диагнозом рака ободочной или прямой кишки, которым было проведено специализированное хирургическое лечение. Эта динамика обусловлена как ростом заболеваемости КРР, так и повышением онкологической настороженности врачей-онкологов поликлинического звена, а также повышением хирургической активности стационара городского онкодиспансера, где проводится большинство оперативных вмешательств по поводу КРР в городе Алматы.

Динамику увеличения числа больных, получивших специализированное лечение, в том числе хирургическое по поводу КРР отражает таблица 4.

Табл. 4. Больные КРР, получившие специализированное лечение, в том числе хирургическое

локали- зация	год	Подлежало лечению из впервые взятых на учет в отчетном году	Вид лечения		
			Только оперативн.	Комбинированное (операция+ лучевая терапия)	Комплексное (операция+ химиотерапия+ лучевая терапия)
Рак ободочн. кишки	2007	106	57	0	15
	2008	119	64	0	25
	2009	124	65	0	19
	2010	157	83	1	18
Рак прямой кишки	2007	127	61	5	15
	2008	123	48	3	16
	2009	111	52	0	19
	2010	127	59	3	11

За последние 5 лет существенно вырос процент первично верифицированных (подтвержденных) диагнозов при раке ободочной (72,3%) и прямой (83,9%) кишок, основанных на изучении биопсийного материала, полученного при колоноскопии или ректороманоскопии. Вместе с тем следует отметить довольно высокую частоту (около 20% случаев) сочетания доброкачественных полипов и раковой опухоли в том или ином отделе прямой или ободочной кишок. Основной нозологической формой (96,4%) рака толстой кишки является аденокарцинома различной степени дифференцировки. Встречаются и другие формы злокачественных опухолей: плоскоклеточный рак, недифференцированный рак, гастроинтестинальные стромальные опухоли, и другие.

Хирургическое лечение остается ведущим методом лечения при всех стадиях заболевания, однако,

если на ранних стадиях болезни только операция может быть признана радикальной и не требующей дополнительного медикаментозного или лучевого лечения, то при III и IV стадиях процесса она должна дополняться адьювантной полихимиотерапией [14]. Характер оперативных вмешательств при КРР определяется анатомическими особенностями органа и локализацией первичной опухоли, наличием или отсутствием толстокишечной непроходимости. В торакоабдоминальном отделении ГОД за рассматриваемый период (2007-2010 гг.) по поводу РОК оперировано 304 пациента, по поводу РПК – 271 больной. Показатель морфологической верификации диагноза до операции составил 72% при РОК, 82% при РПК. Большинство (97%) злокачественных опухолей было представлено аденокарциномами (послеоперационный диагноз) различной степени дифференцировки. В зависимости от локализации опухоли и наличия толстокишечной непроходимости выполнялись одно- и двухэтапные операции (удаление опухоли, в дальнейшем – при отсутствии местного рецидива и отдаленных метастазов – восстановление левого фланга ободочной кишки и ликвидация колостомы с восстановлением естественного пассажа каловых масс по кишечнику). Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (операция Кеню-Майлса) была выполнена в 39% случаев при низко расположенных опухолях, когда сохранять анальный сфинктер рискованно, а также в случае неудовлетворительного функционального состояния пациента, угрозы несостоятельности первичного толсто-толстокишечного анастомоза, при местно-распространенном опухолевом процессе. Большинству больных при наличии показаний выполнялись функционально-

щадящие операции - передняя резекция прямой кишки и сигмы (в т.ч. низкие передние резекции) в 58% случаев и брюшно-анальная резекция прямой кишки 3%.

Наиболее частыми послеоперационными осложнениями у больных, оперированных по поводу РОК и РПК были несостоятельность первичного межкишечного анастомоза (12%), параколомостомические затеки (4%) и инфильтраты в брюшной полости (8%). По данным ежегодного отчета торакоабдоминального отделения, где проводятся эти операции, количество и характер послеоперационных осложнений и показатель летальности после радикальных операций по поводу КРР не отличаются от таковых в ведущих специализированных клиниках. Все больные находятся под динамическим диспансерным наблюдением поликлиники ГОД, как того требуют стандарты диагностики и

лечения [15].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

в г. Алматы, как и в республике в целом, отмечается рост заболеваемости и смертности от колоректального рака.

отмечается увеличение показателя заболеваемости КРР среди лиц молодого возраста.

ведущим методом лечения больных КРР остается хирургический, дополняемый в некоторых случаях адъювантной лекарственной или лучевой терапией.

городской онкологический диспансер является ведущим медицинским учреждением онкологического профиля в городе, где оказывается специализированная помощь больным КРР. За последние 3 года отмечается повышение хирургической активности стационара, увеличение числа выполняемых операций при раке ободочной и прямой кишки.

приоритетным направлением работы отделения является выполнение функционально-щадящих операций при КРР, при наличии строгих показаний и оценке возможного риска с позиций онкологического радикализма. Это направление можно считать первичной хирургической реабилитацией такой сложной категории пациентов, какими являются больные раком ободочной и прямой кишки.

Литература

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2002 г. ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. М., МИА, 2004. - 256 с.
2. Сакаева Д.Д. Адъювантное и неадъювантное лечение больных раком ободочной и прямой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 103-111.
3. Патютко Ю.И., Сагайдак И.В., Поляков А.Н. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени. //Русский медицинский журнал. Онкология. 2009. - т. 17. - № 13. - с. 3-10.
4. Земляной В.П., Трофимова Т.Н., Непомнящая С.Л., Дементьева Т.В. Современные методы диагностики и оценки степени распространенности рака ободочной и прямой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - №2. - с. 71-80.
5. Имянитов Е.Н. Клинико-молекулярные аспекты колоректального рака: этиопатогенез, профилактика, индивидуализация лечения. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 65-70.
6. Имянитов Е.Н., Хансон К.П. Молекулярная онкология: клинические аспекты. СПб., Издательский дом СПбМАПО, 2007. - с. 6-9.
7. Гарькавцева Р.Ф., Белев Н.Ф. Генетические аспекты рака толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. тр. Под ред. Переводчиковой Н.И. М., «Клевер принт», 2001. - с. 10-16.
8. Любченко Л.Н. Клинико-генотипические варианты семейного рака толстой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 132-136.
9. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д., и др. Современная стратегия создания высокотехнологичных программ лечения в онкопроктологии. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. - с. 102-108.
10. Maughan T., James R., Kerr D. et al. Continuous vs intermittent chemotherapy for advanced colorectal cancer: preliminary results of the MRC Cr06b randomized trial. //Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 2001. - vol. 20. - p. 125 (abstract).
11. Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W. Комбинация бевацизумаба с иринотеканом, фторурацилом и лейковорином для лечения метастатического колоректального рака. //The New England Journal of Medicine. 2004. - vol. 350. - № 23. - p. 2335-42.
12. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год (статистические материалы). А., 2010. - 108 с.
13. Веселов В.В., Власов С.Б., Кузьмин А.И., и др. Новые подходы в эндоскопической диагностике и лечении новообразований толстой кишки. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. - с. 150-154.
14. Моисеенко В.М., Орлова Р.В. Адъювантное лечение больных раком ободочной кишки. //Практическая онкология. 2000. - № 1. - с. 19-23.
15. Тюляндин С.А. Диспансерное наблюдение за больными раком ободочной кишки после радикального лечения. //Практическая онкология. 2000. - № 1 (март). - с. 24-26.